VIH — 50 QCM de révision

Questions à cinq propositions (A–E). Les corrigés argumentés suivent les 50 questions. Le nombre de réponses attendues est indiqué dans chaque encadré.

VIH, CD4 et sida

FACILE

Q01 · Au sujet du VIH, quelles affirmations sont exactes ?

- ☐ A. Le VIH est un rétrovirus.
- ☐ B. Le VIH reste toujours à l'extérieur du génome de la cellule infectée.
- ☐ C. Une charge virale indétectable prouve que tous les réservoirs ont disparu.
- ☐ D. Il peut se multiplier sans cellule hôte.
- ☐ E. Un traitement efficace rend généralement l'infection contrôlable, sans guérison habituelle.

2 réponses attendues

FACILE

Q02 · La charge virale plasmatique VIH permet principalement de…

- ☐ A. Quantifier l'ARN viral circulant.
- ☐ B. Mesurer directement le nombre de lymphocytes T CD4.
- ☐ C. Elle permet, isolément, de poser le diagnostic de stade sida.
- ☐ D. Certifier à elle seule l'absence de réservoir d'ADN viral.
- ☐ E. Elle mesure directement la quantité de plaquettes circulantes.

1 réponse attendue

FACILE

Q03 · Concernant les lymphocytes T CD4, lesquelles de ces propositions sont correctes ?

- ☐ A. Ce sont des cellules immunitaires et non des hormones.
- ☐ B. Ils sont produits exclusivement par le foie.
- ☐ C. Ils sécrètent directement tous les anticorps circulants.
- ☐ D. Le VIH les cible et peut faire diminuer leur nombre.
- ☐ E. Leur numération n'apporte aucune information au suivi.

2 réponses attendues

FACILE

Q04 · Comment différencier infection VIH et stade sida ?

- ☐ A. Toute personne infectée par le VIH est immédiatement au stade sida.
- ☐ B. La majorité des personnes traitées peuvent vivre avec le VIH sans être au stade sida.
- ☐ C. Le sida est un stade avancé de l'infection à VIH défini par des critères spécifiques.
- ☐ D. Une infection opportuniste chez un transplanté signifie automatiquement « sida ».
- ☐ E. Le stade sida peut être révélé par certaines infections opportunistes.

3 réponses attendues

MOYEN

Q05 · Quelle est la signification clinique d'une numération des lymphocytes T CD4 inférieure à 200/mm³ ?

- ☐ A. En dessous, le risque d'infections opportunistes augmente.
- ☐ B. Il suffit, isolément et sans autre critère, pour diagnostiquer tout sida.
- ☐ C. Il aide à reconnaître une immunodépression importante.
- ☐ D. Au-dessus, toute infection, dont la tuberculose, devient impossible.
- ☐ E. Il est utile pour réfléchir à certaines prophylaxies.

3 réponses attendues

DIFFICILE

Q06 · Que permet la distinction entre ARN viral circulant et ADN proviral ?

- ☐ A. Distinguer mesure de réplication et persistance du virus intégré.
- ☐ B. Conclure que l'ADN proviral correspond à un anticorps.
- ☐ C. Une charge virale supprimée exclut tout rebond après arrêt des ARV.
- ☐ D. Considérer que les deux mesures ont exactement le même objectif.
- ☐ E. L'ADN proviral mesure uniquement les plaquettes.

1 réponse attendue

MOYEN

Q07 · Une personne sous traitement a une charge virale durablement supprimée. Quels messages sont adaptés ?

- ☐ A. Son VIH a nécessairement été éliminé de toutes ses cellules.
- ☐ B. Le traitement doit être poursuivi selon la prescription.
- ☐ C. La suppression virale favorise la restauration des CD4.
- ☐ D. On peut supprimer tout suivi médical.
- ☐ E. Le contrôle durable du VIH améliore fortement les perspectives de vie.

3 réponses attendues

MOYEN

Q08 · Comment l'immunodépression liée au VIH peut-elle influencer le risque de certaines tumeurs ?

- ☐ A. Les CD4 participent aussi à des défenses immunitaires contre des tumeurs.
- ☐ B. Le risque tumoral dépend uniquement du nombre de partenaires sexuels.
- ☐ C. L'immunodépression peut contribuer à un sur-risque de certaines tumeurs.
- ☐ D. Un traitement antirétroviral efficace transforme toute tumeur en infection.
- ☐ E. Tous les cancers observés chez les PVVIH proviennent d'une transformation tumorale des CD4.

2 réponses attendues

FACILE

Q09 · À propos du vocabulaire employé avec les patients, que retenir ?

- ☐ A. « PVVIH » signifie « personne vivant avec le VIH ».
- ☐ B. L'expression « patient VIH » est toujours la formulation recommandée.
- ☐ C. Une terminologie non stigmatisante est importante pour la relation de soins.
- ☐ D. La confidentialité n'a pas d'importance quand le patient est traité.
- ☐ E. Le statut VIH doit être affiché publiquement pour faciliter les soins.

2 réponses attendues

DIFFICILE

Q10 · Une personne immunodéprimée sans infection VIH présente une pneumocystose. Quels raisonnements sont justes ?

- ☐ A. L'infection opportuniste peut aussi exister hors du VIH.
- ☐ B. Il faut automatiquement la déclarer au stade sida.
- ☐ C. L'histoire clinique et la cause de l'immunodépression comptent.
- ☐ D. Toute pneumocystose est une infection virale.
- ☐ E. La présence d'une infection opportuniste ne permet pas à elle seule de conclure à un VIH.

3 réponses attendues

Transmission et évolution clinique

FACILE

Q11 · Quelles voies de transmission du VIH ont été décrites ?

- ☐ A. La transmission sexuelle.
- ☐ B. Le simple fait de parler avec une PVVIH.
- ☐ C. Un contact de sang avec la peau intacte entraîne toujours une infection VIH.
- ☐ D. La transmission parent-enfant ne nécessite jamais aucune prévention.
- ☐ E. Le contact de la main sur une peau saine.

1 réponse attendue

FACILE

Q12 · Concernant « indétectable = intransmissible » (I = I), que faut-il retenir ?

- ☐ A. Le principe concerne la transmission sexuelle sous suppression virale durable.
- ☐ B. Il dispense de toutes les précautions standard lors d'un prélèvement sanguin.
- ☐ C. C'est un message central pour réduire la stigmatisation.
- ☐ D. Il signifie que la personne ne possède plus d'ADN viral intégré.
- ☐ E. Une fois indétectable, le suivi médical peut être définitivement arrêté.

2 réponses attendues

FACILE

Q13 · En l'absence de traitement, comment peut évoluer l'infection VIH ?

- ☐ A. Primo-infection avec réplication virale initiale importante.
- ☐ B. Disparition certaine du virus après quelques jours.
- ☐ C. Phase de latence clinique pouvant être peu symptomatique.
- ☐ D. La diminution des CD4 s'accompagne toujours de la disparition du VIH.
- ☐ E. Absence de réplication virale pendant toute la latence.

2 réponses attendues

FACILE

Q14 · Quels symptômes peuvent évoquer une primo-infection VIH ?

- ☐ A. Fièvre et syndrome pseudo-grippal.
- ☐ B. Éruption cutanée et adénopathies.
- ☐ C. Dyspnée exclusivement, sans autre signe possible.
- ☐ D. Pharyngite ou céphalées.
- ☐ E. Un tableau clinique toujours pathognomonique.

3 réponses attendues

MOYEN

Q15 · À propos du caractère asymptomatique de l'infection VIH, quelles propositions sont justes ?

- ☐ A. La primo-infection peut ne provoquer aucun signe ressenti.
- ☐ B. Une latence clinique peut durer sans symptôme évident.
- ☐ C. L'absence de symptôme suffit à écarter toute contamination récente.
- ☐ D. Le virus peut rester détectable malgré une latence clinique.
- ☐ E. La latence est synonyme de guérison définitive.

3 réponses attendues

DIFFICILE

Q16 · Quels éléments biologiques sont évoqués pendant la primo-infection ?

- ☐ A. Une possible cytolyse hépatique.
- ☐ B. Une thrombopénie est systématiquement présente chez tous les patients.
- ☐ C. Une absence obligatoire de toute anomalie sanguine.
- ☐ D. L'hémogramme est toujours parfaitement normal pendant la primo-infection.
- ☐ E. Une numération CD4 à elle seule toujours suffisante pour diagnostiquer le VIH.

1 réponse attendue

MOYEN

Q17 · Quelle conduite face à un zona est cohérente avec le cours ?

- ☐ A. Il faut conclure que tout zona signifie VIH.
- ☐ B. Le zona peut faire envisager une immunodépression.
- ☐ C. Il peut conduire à proposer une évaluation et un dépistage VIH adaptés.
- ☐ D. Il ne survient jamais chez une personne immunocompétente.
- ☐ E. Un zona ne peut jamais conduire à envisager un dépistage VIH.

2 réponses attendues

DIFFICILE

Q18 · À propos des données épidémiologiques évoquées pendant le cours, quelle lecture est prudente ?

- ☐ A. Les chiffres doivent être rattachés à leur année de référence.
- ☐ B. Les chiffres d'une diapositive de 2022 décrivent nécessairement la situation en 2026.
- ☐ C. Le cours signale une épidémie mondiale persistante malgré les traitements.
- ☐ D. En cas de contradiction, on adopte sans contrôle le chiffre le plus élevé.
- ☐ E. Une catégorie de population suffit à présumer de la sérologie d'une personne.

2 réponses attendues

MOYEN

Q19 · Quelle différence entre contact quotidien et soin invasif avec une PVVIH ?

- ☐ A. Le contact social ordinaire n'exige pas de protection exceptionnelle liée au VIH.
- ☐ B. Les précautions standard dépendent aussi du geste et du risque de sang.
- ☐ C. Une conversation avec une PVVIH impose systématiquement un masque FFP2.
- ☐ D. Un prélèvement sanguin justifie la prévention habituelle des expositions au sang.
- ☐ E. Les gants sont obligatoires lors de tout contact visuel avec une PVVIH.

3 réponses attendues

MOYEN

Q20 · Pourquoi la prévention du VIH ne doit-elle pas reposer sur une logique de culpabilisation ?

- ☐ A. Elle peut empêcher le dialogue et l'accès au dépistage.
- ☐ B. L'enseignante encourage une information sans jugement.
- ☐ C. Le nombre de partenaires suffit à poser le diagnostic.
- ☐ D. PrEP, préservatif et dépistage doivent être discutés avec la personne.
- ☐ E. La prévention est inutile si la personne est anxieuse.

3 réponses attendues

Infections opportunistes et complications

FACILE

Q21 · Devant une infection opportuniste chez une PVVIH, quels axes de prise en charge sont évoqués ?

- ☐ A. Traiter l'infection opportuniste identifiée.
- ☐ B. Contrôler l'infection VIH par un traitement adapté.
- ☐ C. Arrêter nécessairement les antirétroviraux de façon définitive.
- ☐ D. Il faut renoncer à tout suivi de la récupération immunitaire.
- ☐ E. Ignorer les autres infections opportunistes possibles.

2 réponses attendues

FACILE

Q22 · Concernant la tuberculose au cours d'une infection VIH, quelles propositions sont justes ?

- ☐ A. Elle peut apparaître même avec des CD4 relativement conservés.
- ☐ B. Elle est exclusivement extrapulmonaire chez les PVVIH.
- ☐ C. Une tuberculose doit faire envisager un dépistage VIH.
- ☐ D. Une tuberculose pulmonaire contagieuse impose uniquement des précautions gouttelettes.
- ☐ E. Les précautions gouttelettes suffisent nécessairement dans toute tuberculose pulmonaire.

2 réponses attendues

FACILE

Q23 · Quels signes cliniques peuvent faire évoquer une pneumocystose chez une personne immunodéprimée ?

- ☐ A. Toux.
- ☐ B. Dyspnée.
- ☐ C. La pneumocystose est causée par un virus herpétique.
- ☐ D. Hémiplégie isolée comme manifestation pulmonaire typique.
- ☐ E. Nodules violacés cutanés comme signe cardinal.

2 réponses attendues

MOYEN

Q24 · À propos du cotrimoxazole et de la pneumocystose, que retient-on ?

- ☐ A. Il est cité comme traitement de la pneumocystose.
- ☐ B. Il est évoqué à visée prophylactique lors d'une forte immunodépression.
- ☐ C. Il remplace tous les antirétroviraux du VIH.
- ☐ D. Le seuil de 200 CD4/mm³ est un repère de cours pour discuter une prévention.
- ☐ E. Il est un vaccin contre le VIH.

3 réponses attendues

MOYEN

Q25 · Quels signes ou situations orientent vers une toxoplasmose cérébrale ?

- ☐ A. Déficit neurologique focal de type hémiplégie.
- ☐ B. Crise d'épilepsie.
- ☐ C. Abcès ou lésions cérébrales à l'imagerie.
- ☐ D. Rétinite comme unique signe obligatoire.
- ☐ E. Présence obligatoire d'une tuberculose pulmonaire associée.

3 réponses attendues

MOYEN

Q26 · La cryptococcose opportuniste est évoquée avec quelles caractéristiques ?

- ☐ A. Une méningite ou des céphalées fébriles.
- ☐ B. Le CMV n'atteint jamais le tube digestif.
- ☐ C. Le CMV ne peut avoir aucune atteinte neurologique.
- ☐ D. Une gastro-entérite sans atteinte neurologique possible.
- ☐ E. Un traitement reposant uniquement sur le préservatif.

1 réponse attendue

MOYEN

Q27 · Quelles atteintes emblématiques du CMV sont décrites ?

- ☐ A. Rétinite pouvant menacer la vision.
- ☐ B. Colite avec diarrhées.
- ☐ C. Un traitement efficace exclut toute inflammation cardiovasculaire.
- ☐ D. Une pneumocystose due au même agent CMV.
- ☐ E. Une maladie exclusivement cutanée.

2 réponses attendues

MOYEN

Q28 · Quels liens entre VIH et cancers sont présentés ?

- ☐ A. Kaposi est associé au HHV-8.
- ☐ B. Certains cancers liés au papillomavirus peuvent être plus fréquents.
- ☐ C. Une infection VIH rend tous les lymphomes impossibles.
- ☐ D. Tous les cancers des PVVIH sont causés directement par le VIH lui-même.
- ☐ E. Un traitement antirétroviral rend tous les dépistages inutiles.

2 réponses attendues

DIFFICILE

Q29 · Pourquoi surveille-t-on le risque cardiovasculaire chez une personne vivant avec le VIH ?

- ☐ A. Une réplication persistante peut entretenir une inflammation.
- ☐ B. Cette inflammation est présentée comme l'un des facteurs de complications.
- ☐ C. Une atteinte cardiovasculaire est impossible en dehors du stade sida.
- ☐ D. L'évaluation globale des comorbidités reste pertinente.
- ☐ E. Il suffit de compter les CD4 pour exclure tout facteur cardiovasculaire.

3 réponses attendues

FACILE

Q30 · Quelles associations agent–manifestation sont correctes ?

- ☐ A. Pneumocystose — infection fongique pulmonaire.
- ☐ B. Toxoplasmose — abcès cérébraux possibles.
- ☐ C. Cryptococcose — méningite possible.
- ☐ D. CMV — maladie de Kaposi.
- ☐ E. Tuberculose — infection exclusivement virale.

3 réponses attendues

Dépistage, traitement et maternité

FACILE

Q31 · Quels moyens de dépistage du VIH sont cités ?

- ☐ A. Sérologie VIH.
- ☐ B. Le TROD ne mesure que le nombre de CD4.
- ☐ C. Une photographie des lésions cutanées est un autotest VIH.
- ☐ D. Simple numération des lymphocytes CD4 comme diagnostic suffisant.
- ☐ E. Photographie des lésions cutanées comme preuve de VIH.

1 réponse attendue

MOYEN

Q32 · Un autotest VIH revient positif. Quel message est adapté ?

- ☐ A. Un examen de confirmation doit être organisé.
- ☐ B. Le diagnostic définitif et le stade sida sont établis immédiatement par cet autotest.
- ☐ C. La personne doit être orientée vers un parcours de soins adapté.
- ☐ D. La confidentialité est inutile dès qu'un autotest est réactif.
- ☐ E. Un autotest positif permet de prescrire soi-même des antirétroviraux.

2 réponses attendues

FACILE

Q33 · Lors du suivi d'une PVVIH, quels éléments sont centraux ?

- ☐ A. Charge virale VIH.
- ☐ B. Numération T CD4.
- ☐ C. La charge virale indétectable élimine toute question d'observance.
- ☐ D. Mesure isolée de la glycémie comme seul examen du VIH.
- ☐ E. Arrêt systématique du suivi dès la suppression virale.

2 réponses attendues

MOYEN

Q34 · Pourquoi rechercher d'autres IST chez une personne ayant un VIH ?

- ☐ A. Il peut y avoir des co-infections.
- ☐ B. Le cours cite notamment syphilis, hépatites et infections à Chlamydia/gonocoque.
- ☐ C. Une infection VIH protège des autres IST.
- ☐ D. La prévention et le dépistage restent nécessaires.
- ☐ E. Le test VIH détecte automatiquement toutes les IST.

3 réponses attendues

FACILE

Q35 · Quels principes guident le traitement antirétroviral (ARV) d'une infection par le VIH ?

- ☐ A. Il est proposé dès que possible après le diagnostic.
- ☐ B. Il doit généralement être poursuivi au long cours, sans arrêt autonome.
- ☐ C. Il a pour objectif une suppression durable de la charge virale.
- ☐ D. Il est arrêté dès la première mesure indétectable.
- ☐ E. Il consiste toujours exclusivement en trois comprimés distincts par jour.

3 réponses attendues

MOYEN

Q36 · À propos des schémas ARV évoqués, lesquelles des propositions sont justes ?

- ☐ A. Le cours mentionne des bithérapies possibles dans certaines situations.
- ☐ B. Il n'existe jamais de comprimé associant plusieurs antirétroviraux.
- ☐ C. Le choix des ARV ne dépend jamais des comorbidités.
- ☐ D. Tout patient reçoit obligatoirement la même association de médicaments.
- ☐ E. Le nombre de comprimés permet à lui seul d'évaluer l'efficacité.

1 réponse attendue

DIFFICILE

Q37 · Quels sont les exemples de traitements antirétroviraux combinés à identifier ?

- ☐ A. Biktarvy.
- ☐ B. Dovato.
- ☐ C. Chaque PVVIH doit recevoir la même molécule, indépendamment des co-infections.
- ☐ D. Cotrimoxazole comme combinaison curative du VIH.
- ☐ E. Ganciclovir comme trithérapie antirétrovirale standard.

2 réponses attendues

MOYEN

Q38 · Une personne vivant avec le VIH, ayant un contrôle virologique durable, souhaite une grossesse. Quels messages sont adaptés ?

- ☐ A. Un projet parental peut être envisagé avec un suivi spécialisé.
- ☐ B. Une PMA est toujours obligatoire.
- ☐ C. La charge virale n'a aucune importance pendant la grossesse.
- ☐ D. L'observance et le suivi de la charge virale pendant la grossesse sont importants.
- ☐ E. Une grossesse doit être systématiquement interdite aux PVVIH.

2 réponses attendues

DIFFICILE

Q39 · Concernant l'allaitement chez une PVVIH contrôlée, quel raisonnement est approprié ?

- ☐ A. L'allaitement est toujours interdit, sans exception.
- ☐ B. La séance évoque une décision possible dans certaines situations sélectionnées.
- ☐ C. Le suivi de la mère et du nourrisson reste essentiel.
- ☐ D. L'absence de risque doit être garantie sans aucune condition.
- ☐ E. L'équipe spécialisée doit discuter bénéfices, conditions et prévention avec la patiente.

3 réponses attendues

MOYEN

Q40 · Quel rôle attribuer à la prophylaxie néonatale lors d'une grossesse chez une PVVIH ?

- ☐ A. Elle peut faire partie de la stratégie de prévention pour le nouveau-né.
- ☐ B. Elle remplace l'ensemble du suivi virologique maternel.
- ☐ C. Sa durée et ses modalités sont décidées selon la situation clinique.
- ☐ D. Le cours mentionne une prophylaxie du nourrisson dans le parcours spécialisé.
- ☐ E. Elle signifie que tous les bébés sont déjà infectés.

3 réponses attendues

PrEP, TPE et rôle infirmier

FACILE

Q41 · À propos de la prophylaxie pré-exposition (PrEP), que faut-il retenir ?

- ☐ A. Elle s'adresse à des personnes VIH négatives exposées à un risque.
- ☐ B. Elle n'est proposée qu'après une exposition avérée.
- ☐ C. Elle utilise exclusivement un vaccin vivant.
- ☐ D. Elle est identique à un vaccin.
- ☐ E. Elle permet d'abandonner automatiquement le dépistage des autres IST.

1 réponse attendue

MOYEN

Q42 · Quels messages sont exacts concernant la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH ?

- ☐ A. Elle peut être discutée après une IST, selon l'exposition et les besoins.
- ☐ B. Elle remplace toutes les mesures de prévention des autres IST.
- ☐ C. Des modalités orales sont évoquées pendant la séance.
- ☐ D. Toutes les modalités injectables sont disponibles partout et sans condition.
- ☐ E. Elle traite à elle seule une infection VIH diagnostiquée.

2 réponses attendues

FACILE

Q43 · Qu'est-ce qui différencie PrEP et traitement post-exposition (TPE/PEP) ?

- ☐ A. La PrEP intervient avant une exposition potentielle.
- ☐ B. Le TPE est discuté après une exposition à risque.
- ☐ C. Une consultation après plusieurs mois présente la même urgence pour le TPE.
- ☐ D. La PrEP et le TPE correspondent à une vaccination identique.
- ☐ E. Le TPE est indiqué automatiquement après n'importe quel contact social.

2 réponses attendues

MOYEN

Q44 · Quelles données d'une exposition récente doivent être recueillies en priorité ?

- ☐ A. Le délai depuis le contact.
- ☐ B. La nature de l'exposition et du liquide concerné.
- ☐ C. Des éléments utiles sur le contexte et la personne source, si disponibles.
- ☐ D. Le jugement moral porté sur la vie sexuelle.
- ☐ E. La supposition qu'un contact courant est toujours dangereux.

3 réponses attendues

MOYEN

Q45 · Quels repères de TPE sont explicitement donnés pendant le cours ?

- ☐ A. Une prise en charge dans les 72 h suivant l'exposition, idéalement très précoce.
- ☐ B. Un traitement antirétroviral de 28 jours est évoqué.
- ☐ C. Un avis médical urgent est nécessaire.
- ☐ D. Il faut toujours attendre la survenue d'une fièvre avant d'agir.
- ☐ E. Le TPE est une immunisation vaccinale à dose unique.

3 réponses attendues

MOYEN

Q46 · Après un accident d'exposition au sang (AES), quelles étapes sont citées ?

- ☐ A. Une évaluation rapide du risque et une orientation médicale.
- ☐ B. Aucun examen de suivi n'est utile après un AES.
- ☐ C. Un AES chez un IDE ne nécessite jamais une déclaration d'accident du travail.
- ☐ D. Une décision thérapeutique autonome de l'IDE sans consultation.
- ☐ E. L'absence de toute traçabilité si le patient source est inconnu.

1 réponse attendue

FACILE

Q47 · Dans le cas de M. M., anxieux après un rapport non protégé, quelle posture infirmière est adaptée ?

- ☐ A. Accueillir l'anxiété sans culpabiliser.
- ☐ B. Informer que des traitements efficaces existent et organiser le dépistage.
- ☐ C. La date du contact ne sert jamais à déterminer l'urgence.
- ☐ D. Annoncer immédiatement qu'il va mourir du sida.
- ☐ E. Affirmer sans test qu'il a forcément contracté le VIH.

2 réponses attendues

DIFFICILE

Q48 · Un étudiant propose de résoudre les huit situations du cas final en cochant « TPE oui/non ». Que répondre à partir des sources fournies ?

- ☐ A. La correction de ce dernier exercice n'a pas été donnée oralement.
- ☐ B. Il faut fabriquer des réponses pour compléter la banque.
- ☐ C. L'analyse doit distinguer type d'exposition, délai et contexte.
- ☐ D. Les huit situations ont toutes reçu une correction orale officielle.
- ☐ E. Tout cas cité dans une diapositive justifie automatiquement un TPE.

2 réponses attendues

FACILE

Q49 · Que comprennent les précautions et le rôle IDE auprès d'une PVVIH ?

- ☐ A. Appliquer les précautions standard en fonction du soin.
- ☐ B. Utiliser les gants lors de gestes exposant au sang selon les bonnes pratiques.
- ☐ C. Préserver la confidentialité et éviter la stigmatisation.
- ☐ D. Imposer un isolement Air à toute PVVIH sans tuberculose.
- ☐ E. Renoncer à tout examen clinique de peur d'une contagion par simple contact.

3 réponses attendues

FACILE

Q50 · Quelles composantes font partie de la prise en charge globale d'une personne vivant avec le VIH ?

- ☐ A. Éducation thérapeutique et compréhension du traitement.
- ☐ B. Soutien psychosocial et accès aux ressources si précarité.
- ☐ C. Coordination des professionnels et accompagnement sans jugement.
- ☐ D. Suivi limité à une ordonnance sans dialogue.
- ☐ E. Abandon de l'information sur les vaccinations et autres IST.

3 réponses attendues

Corrigés argumentés

Q01 — Réponses : A, E.

Le VIH est un rétrovirus dont l'ARN est rétrotranscrit en ADN, puis intégré ; les antirétroviraux contrôlent la réplication sans éliminer les réservoirs.

Propositions à écarter : C est faux : indétectable ne signifie pas éradiqué. D est faux : la multiplication du virus requiert une cellule. B : Le VIH peut intégrer son ADN dans le génome cellulaire.

Q02 — Réponses : A.

La charge virale est une mesure d'ARN viral, utilisée pour suivre la réplication et la réponse thérapeutique.

Propositions à écarter : B : le nombre de CD4 est un autre examen. D : un réservoir proviral peut persister malgré une charge virale basse. C : La charge virale seule ne définit pas le stade sida. E : La numération plaquettaire est un autre examen.

Q03 — Réponses : A, D.

Les T CD4 jouent un rôle majeur dans la coordination de l'immunité et sont des cibles du VIH.

Propositions à écarter : C : la production d'anticorps relève des lymphocytes B/plasmocytes. E : la numération CD4 renseigne sur l'immunodépression. B : Les lymphocytes T CD4 sont des cellules immunitaires, non des protéines hépatiques.

Q04 — Réponses : B, C, E.

VIH désigne l'infection ; sida désigne un stade avancé, notamment lié à des affections définissant ce stade.

Propositions à écarter : A confond infection et stade. D confond sida avec d'autres causes d'immunodépression.

Q05 — Réponses : A, C, E.

La numération des CD4 utilise le seuil de 200 CD4/mm³ comme repère de vulnérabilité et de prévention de certaines infections.

Propositions à écarter : B : le sida ne se résume pas au seul seuil. D : la tuberculose peut survenir malgré des CD4 conservés.

Q06 — Réponses : A.

L'ARN plasmatique reflète la réplication mesurée ; l'ADN proviral correspond à l'intégration du virus dans des cellules, participant à la persistance.

Propositions à écarter : B : ADN viral ≠ anticorps. D : examens et significations distincts. C : Le VIH peut recommencer à se répliquer après l'arrêt du traitement. E : L'ADN proviral est un marqueur viral, non une mesure de l'hémogramme.

Q07 — Réponses : B, C, E.

Le maintien du traitement et du suivi permet de contrôler le virus et de restaurer l'immunité ; vivre avec le VIH traité peut être proche de la normale.

Propositions à écarter : A : réservoirs persistants. D : suivi et observance restent nécessaires.

Q08 — Réponses : A, C.

L'enseignante relie l'affaiblissement de l'immunité et certains cancers associés notamment à des virus oncogènes.

Propositions à écarter : B : ce n'est pas le mécanisme exposé. D : cancer et infection ne sont pas interchangeables. E : Les associations tumorales sont diverses, notamment avec HPV et HHV-8.

Q09 — Réponses : A, C.

Le cours insiste sur l'expression PVVIH et la lutte contre les stéréotypes et la stigmatisation.

Propositions à écarter : B : étiquetage réducteur déconseillé dans la séance. D : confidentialité indispensable. E : Le secret et la confidentialité demeurent indispensables.

Q10 — Réponses : A, C, E.

Le cours compare le VIH à d'autres immunodépressions (dont la transplantation) : une infection opportuniste n'établit pas à elle seule le sida.

Propositions à écarter : B : sida suppose l'infection VIH et des critères spécifiques. D : la pneumocystose est due à un champignon.

Q11 — Réponses : A.

Le cours décrit les voies sexuelle, sanguine et parent-enfant ; les contacts sociaux ordinaires ne transmettent pas le VIH.

Propositions à écarter : B et E relèvent de contacts courants ne constituant pas une voie d'infection VIH. C : Le risque dépend du type d'exposition et d'une porte d'entrée. D : Un suivi spécialisé et des mesures préventives peuvent être nécessaires.

Q12 — Réponses : A, C.

I = I signifie qu'une personne durablement indétectable sous traitement ne transmet pas sexuellement le VIH ; le cours insiste sur le bénéfice clinique et social de ce message.

Propositions à écarter : B : précautions standard maintenues. D : réservoir viral non éliminé. E : Le suivi reste important malgré la suppression virale.

Q13 — Réponses : A, C.

Sans traitement, le cours décrit une primo-infection, une latence clinique puis une immunodépression progressive.

Propositions à écarter : B : persistance virale. E : latence clinique ≠ virus biologiquement indétectable. D : La diminution des CD4 résulte de l'activité de l'infection, pas de sa guérison.

Q14 — Réponses : A, B, D.

La séance mentionne fièvre, myalgies, pharyngite, céphalées, éruption et adénopathies, avec possibilité d'absence de symptômes.

Propositions à écarter : C : la clinique est variable. E : ces signes ne permettent pas, seuls, le diagnostic.

Q15 — Réponses : A, B, D.

L'absence de symptôme ne garantit pas l'absence de VIH ; pendant la latence, le virus n'a pas disparu.

Propositions à écarter : C : une exposition peut nécessiter des examens. E : la persistance virale continue.

Q16 — Réponses : A.

Le cours évoque notamment cytolyse, syndrome mononucléosique, lymphopénie/neutropénie et thrombopénie.

Propositions à écarter : C : anomalies possibles. E : diagnostic VIH par examens adaptés, non par CD4 isolés. B : Une thrombopénie peut exister mais n'est pas obligatoire. D : La séance décrit des anomalies possibles des cellules sanguines.

Q17 — Réponses : B, C.

L'enseignante mentionne le zona comme signe pouvant inciter à rechercher une cause d'immunodépression, sans en faire une preuve de VIH.

Propositions à écarter : A et D : un zona a d'autres causes et survient aussi sans VIH. E : L'enseignante cite le zona comme une situation pouvant mener au dépistage.

Q18 — Réponses : A, C.

La présentation cite des repères datés et comporte une divergence pour un chiffre français : le raisonnement attendu porte sur dates, dépistage et prudence.

Propositions à écarter : B : ne pas actualiser sans données. E : aucune identité/pratique ne permet de conclure individuellement. D : Une contradiction source doit être explicitement réservée.

Q19 — Réponses : A, B, D.

Le cours insiste sur l'absence de risque social ordinaire et l'application de précautions standard lors des gestes exposant au sang.

Propositions à écarter : C et E : protections exceptionnelles liées au seul statut non justifiées.

Q20 — Réponses : A, B, D.

La séance demande une communication non moralisatrice et personnalisée, notamment pour les personnes vulnérables ou anxieuses.

Propositions à écarter : C : pas de diagnostic par comportement. E : information adaptée reste utile.

Q21 — Réponses : A, B.

La double approche soulignée à l'oral vise le traitement de l'infection en cours et le contrôle du VIH pour restaurer les défenses.

Propositions à écarter : C et E sont contraires aux objectifs ; le calendrier thérapeutique reste médical et individualisé. D : La récupération immunitaire fait partie de l'objectif du traitement.

Q22 — Réponses : A, C.

L'enseignante insiste sur dépistage VIH devant une tuberculose et précautions Air en cas de tuberculose pulmonaire contagieuse.

Propositions à écarter : B : atteintes pulmonaires fréquentes, mais aussi extrapulmonaires. E : le cours distingue Air de gouttelettes. D : Le cours insiste sur les précautions Air.

Q23 — Réponses : A, B.

La pneumocystose est décrite comme une infection fongique pulmonaire pouvant entraîner toux, dyspnée et fièvre, parfois gravité respiratoire.

Propositions à écarter : D : évoque plutôt un problème neurologique. E : fait penser à Kaposi, non à une pneumocystose. C : La pneumocystose est une infection fongique.

Q24 — Réponses : A, B, D.

Le cours mentionne cotrimoxazole pour traiter et prévenir la pneumocystose chez certaines PVVIH avec CD4 bas.

Propositions à écarter : C et E : antibactérien/antipneumocystose ≠ traitement complet du VIH ni vaccin.

Q25 — Réponses : A, B, C.

L'atteinte cérébrale toxoplasmique peut donner déficit focal, crises et lésions à l'imagerie ; l'enseignante évoque un tableau initialement confondu avec un AVC.

Propositions à écarter : D : atteinte oculaire non présentée comme signe cardinal ici. E : aucune tuberculose obligatoire.

Q26 — Réponses : A.

Cryptococcose : infection fongique souvent neurologique, parfois avec hypertension intracrânienne et ponctions lombaires répétées ; repère oral CD4 souvent très bas.

Propositions à écarter : D : l'atteinte neurologique est centrale dans la présentation. E : la prise en charge est antifongique spécialisée. B : La colite à CMV est évoquée. C : Une atteinte neurologique est possible dans certaines situations.

Q27 — Réponses : A, B.

Le CMV peut provoquer rétinite, colite, et certaines atteintes neurologiques ou pulmonaires ; des antiviraux spécifiques sont cités.

Propositions à écarter : D : pneumocystose = autre agent fongique. E : le CMV n'est pas limité à la peau. C : Le suivi cardiovasculaire reste pertinent.

Q28 — Réponses : A, B.

Le cours cite sarcome de Kaposi/HHV-8, lymphomes et certaines tumeurs associées aux HPV.

Propositions à écarter : D : plusieurs agents et mécanismes entrent en jeu. E : prévention et suivi restent nécessaires. C : Le cours évoque un sur-risque de certains lymphomes.

Q29 — Réponses : A, B, D.

La séance relie réplication/inflammation et complications cardiovasculaires, d'où une approche globale.

Propositions à écarter : C : les comorbidités ne sont pas limitées au sida. E : les CD4 ne remplacent pas l'évaluation clinique.

Q30 — Réponses : A, B, C.

Les trois premières associations correspondent aux tableaux typiques explicités par l'enseignante.

Propositions à écarter : D : Kaposi est associé au HHV-8. E : tuberculose due à une mycobactérie, non à un virus.

Q31 — Réponses : A.

La séance cite sérologie, TROD et autotest ; les résultats réactifs rapides nécessitent une confirmation selon le parcours diagnostique.

Propositions à écarter : D et E : ne remplacent pas le diagnostic biologique VIH. B : Le TROD est utilisé pour le dépistage du VIH et non la numération CD4. C : Le diagnostic passe par des tests biologiques adaptés.

Q32 — Réponses : A, C.

L'enseignante rappelle de confirmer un test rapide réactif par la démarche biologique adaptée et d'accompagner la personne.

Propositions à écarter : B : résultat rapide non suffisant pour conclure au stade. E : traitement et prescription exigent une prise en charge médicale. D : Le secret et le respect de la personne demeurent essentiels.

Q33 — Réponses : A, B.

La charge virale, les CD4 et l'observance permettent de suivre contrôle de réplication, récupération immunitaire et continuité des soins.

Propositions à écarter : D : glycémie non spécifique. E : suivi maintenu même sous contrôle virologique. C : L'observance doit rester accompagnée sur le long terme.

Q34 — Réponses : A, B, D.

L'enseignante insiste sur la recherche d'autres IST, car des expositions communes peuvent conduire à plusieurs infections.

Propositions à écarter : C : VIH n'immunise pas contre les IST. E : dépistages spécifiques nécessaires.

Q35 — Réponses : A, B, C.

Le traitement précoce et durable est fortement souligné ; il contrôle la réplication et vise une charge virale indétectable.

Propositions à écarter : D : arrêter expose à une reprise de réplication. E : schémas simplifiés possibles et nombre de comprimés variable.

Q36 — Réponses : A.

L'enseignante cite bi-/trithérapies, comprimés combinés, et individualisation selon co-infections, grossesse, interactions et résistances.

Propositions à écarter : D et E : pas de schéma universel ni de jugement par simple nombre de comprimés. B : Le cours décrit des combinaisons en un comprimé. C : Les interactions, co-infections et comorbidités guident le choix.

Q37 — Réponses : A, B.

Biktarvy, Dovato et Delstrigo sont les exemples de comprimés combinés cités oralement ; les molécules doivent être distinguées de celles des infections opportunistes.

Propositions à écarter : D : cotrimoxazole est évoqué pour pneumocystose. E : ganciclovir pour CMV. C : La prise en charge est individualisée.

Q38 — Réponses : A, D.

La séance décrit des grossesses spontanées possibles et insiste sur l'observance, le contrôle virologique et le suivi spécialisé.

Propositions à écarter : B et E : des obligations/interdictions générales que l'enseignante rejette. C : Le contrôle de la charge virale est une priorité de la grossesse.

Q39 — Réponses : B, C, E.

L'enseignante explique l'évolution de la pratique : une discussion encadrée peut être proposée, avec forte vigilance sur la suppression virale et le suivi mère–enfant.

Propositions à écarter : A et D : les formulations absolues ne reflètent pas les nuances du cours.

Q40 — Réponses : A, C, D.

La séance évoque une prophylaxie néonatale et un suivi spécialisé, en complément du contrôle maternel.

Propositions à écarter : B : le suivi maternel est essentiel. E : la prophylaxie vise à prévenir, pas à affirmer une infection.

Q41 — Réponses : A.

La PrEP est une prévention antirétrovirale anticipée, présentée comme un outil majeur de réduction du VIH.

Propositions à écarter : D : pas un vaccin. E : elle ne protège pas de toutes les autres IST. B : PrEP signifie prévention avant une exposition potentielle. C : La PrEP repose sur des antirétroviraux, non un vaccin.

Q42 — Réponses : A, C.

Le cours insiste sur l'information PrEP, notamment pour les personnes exposées et celles ayant eu une autre IST ; il présente voies orale et injectable.

Propositions à écarter : B : prévention des autres IST maintenue. E : traitement du VIH ≠ PrEP seule. D : Le cours indique des modalités et des disponibilités à vérifier localement.

Q43 — Réponses : A, B.

La différence temporelle est essentielle : prévention en amont (PrEP) et prise en charge urgente après exposition (TPE).

Propositions à écarter : D : médicaments antirétroviraux, pas vaccin. E : évaluation de la nature de l'exposition indispensable. C : Le TPE est une urgence évaluée au plus tôt, dans une fenêtre temporelle limitée.

Q44 — Réponses : A, B, C.

La séance rappelle qu'il faut identifier le moment et la nature du contact pour apprécier l'urgence et l'éligibilité au TPE ; l'équipe évalue le contexte.

Propositions à écarter : D : attitude non jugeante. E : une exposition pertinente doit être caractérisée.

Q45 — Réponses : A, B, C.

La séance évoque un TPE urgent, idéalement dans les premières heures, dans les 72 h et pendant 28 jours, à adapter au protocole appliqué.

Propositions à écarter : D : ne pas différer l'évaluation. E : il s'agit d'antirétroviraux, pas d'un vaccin.

Q46 — Réponses : A.

L'enseignante insiste sur l'urgence, les examens de suivi et la déclaration professionnelle pour l'IDE exposé.

Propositions à écarter : D : l'indication du TPE relève de l'évaluation médicale. E : traçabilité et suivi sont indispensables. B : La séance évoque les sérologies et contrôles appropriés. C : Le cours rappelle l'importance de cette déclaration.

Q47 — Réponses : A, B.

Le cas corrigé oralement insiste sur l'écoute, une information rassurante et exacte, le dépistage et le repérage d'un possible TPE.

Propositions à écarter : D : message alarmiste explicitement écarté. E : diagnostic inconnu. C : La date est déterminante pour une éventuelle orientation TPE.

Q48 — Réponses : A, C.

Le cas final sur les expositions est présent dans les captures mais non corrigé dans l'enregistrement. Il doit rester en exercice de raisonnement sans clés inventées.

Propositions à écarter : B et E : une correction non sourcée ou une règle automatique seraient dangereuses. D : La transcription se termine sans correction de ces huit situations.

Q49 — Réponses : A, B, C.

La séance distingue VIH et transmission aérienne : les précautions standard protègent lors des gestes à risque, sans écarter les soins ordinaires.

Propositions à écarter : D : Air concerne notamment une tuberculose pulmonaire contagieuse. E : le contact ordinaire ne transmet pas le VIH.

Q50 — Réponses : A, B, C.

Le cours fait de l'éducation thérapeutique, de l'observance et du soutien social/psychologique des axes prioritaires de soins.

Propositions à écarter : D : relation et accompagnement indispensables. E : vaccination et IST restent abordées.